



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA 3 · COME PARTIRE DAVVERO

Salute & Professioni sanitarie

Come iniziare davvero: primi passi ed esperienze

Guida di orientamento — KIREO

Guida 3 di 3 — dati e riferimenti 2025/26

Come iniziare davvero

Questa guida è per chi ha già capito che l'area Salute & Professioni sanitarie lo attira e ora vuole sapere **come muovere i primi passi**. Non serve arrivare al diploma sapendo fare una medicazione: serve costruire basi solide e verificare, con esperienze vere, se reggi studio, responsabilità, contatto umano e procedure *nel tempo*.

*Un principio che vale per tutta l'area: **non esiste la scorciatoia clinica**. Le attività sanitarie richiedono formazione, abilitazione e supervisione. Tutto ciò che puoi fare adesso è osservare, studiare, educare alla prevenzione e affiancare — mai sostituire personale sanitario.*

1 · Cosa puoi fare già quest'anno

Costruisci un micro-progetto di educazione alla salute

In 2-3 settimane produci qualcosa di verificabile: una guida su come riconoscere le fonti affidabili in salute, un questionario anonimo sui comportamenti di prevenzione in classe con restituzione *solo aggregata*, una mappa dei servizi sanitari e di emergenza del tuo territorio, o un materiale di educazione sanitaria validato da un docente.

*Regola non negoziabile: **non raccogliere dati clinici, diagnosi, farmaci assunti o informazioni identificabili**. Sono dati sensibili, non ti servono per imparare e trattarli senza titolo è un problema legale, non un dettaglio. Conserva obiettivo, fonti istituzionali, bozza, feedback di un adulto competente e versione finale.*

Partecipa ai Campionati delle Scienze Naturali

Organizzati dall'**ANISN** e inseriti nel programma ministeriale di valorizzazione delle eccellenze (già Olimpiadi delle Scienze Naturali). L'edizione 2026 era la ventiquattresima, con categorie per il biennio e per il triennio (Biologia e Scienze della Terra) e fase nazionale dal 9 all'11 maggio. La scuola deve aderire e le scadenze cambiano ogni anno: parlane con il docente di scienze *adesso*, non a primavera.

*Da sapere: **non esiste** una singola olimpiade nazionale permanente che rappresenti medicina, infermieristica, professioni sanitarie e benessere. I Campionati coprono le basi scientifiche, che sono comunque il terreno su cui si gioca il primo anno di quasi tutti questi corsi.*

Chiedi un PCTO mirato, non «uno stage in ospedale»

La richiesta generica ti fa finire a fotocopiare. Chiedi attività coerenti e *consentite a un minorenne*: osservazione di servizi, accoglienza e orientamento dell'utenza con tutor, educazione alla prevenzione, gestione documentale non sanitaria, comunicazione scientifica, analisi di dati solo anonimi e aggregati, supporto a progetti di inclusione, simulazioni formative. **Dove:** ufficio formazione di ASL e aziende ospedaliere, università, IRCCS, Croce Rossa Italiana, associazioni di pazienti, cooperative sociosanitarie, RSA, centri di riabilitazione, farmacie, studi professionali, servizi comunali.

*Prima di firmare chiedi sempre cinque cose: chi è il tutor, com'è coperta l'assicurazione, quali regole valgono sulla privacy, **quali attività ti sono vietate** e quale prodotto finale è previsto.*

Vai a un open day universitario e a uno ITS, con domande preparate

All'università chiedi: quali laboratori e tirocini iniziano già al primo anno? quali prerequisiti servono per anatomia, fisiologia, chimica e statistica? come vengono assegnate le sedi di tirocinio? quali turni e vincoli di frequenza? quale quota di studenti supera gli esami del primo anno? posso parlare con uno studente o

un tutor di tirocinio? **Per Medicina** chiedi in più come funzionano accesso, graduatorie e selezione *nell'anno in cui farai domanda*: le regole cambiano, e vanno lette sul portale MUR e dell'ateneo, non sui forum.

A un **ITS Academy** chiedi: quale figura forma esattamente il corso? quante ore in laboratorio e quante in stage? quali strutture ospitano gli stage? che mansioni svolgono davvero i diplomati? quanti ottengono un contratto entro dodici mesi, e di che tipo? posso vedere il piano didattico e parlare con un diplomato dell'ultima edizione?

Parla con due professionisti di ruoli diversi

Non due medici: meglio un infermiere e una fisioterapista, un medico e un tecnico di laboratorio, un farmacista e un operatore sociosanitario. Venti minuti bastano. Chiedi: com'è un turno tipo? quali responsabilità hai davvero? **quale parte del lavoro non si vede da fuori?** quale percorso e quale abilitazione servono? quale errore fanno i nuovi arrivati? Non chiedere informazioni sui pazienti e non pretendere di assistere ad attività riservate.

2 · Cosa conviene studiare o rafforzare ora

Biologia, chimica, fisica di base, matematica e statistica rendono molto più affrontabili i primi esami e ti permettono di leggere dati clinici e studi. Per infermieristica, tecniche sanitarie e riabilitazione contano anche anatomia, fisiologia, igiene, precisione e capacità di osservare.

Metodo di studio, prima di tutto

In quest'area si studiano testi densi e si accumula molto: serve saper collegare concetti, ripassare in modo attivo e **riedere gli errori invece di rimuoverli**. **Ora**: prova il ripasso attivo (chiudi il libro e riesponi), le flashcard per la terminologia, e l'abitudine di chiedere aiuto *presto* anziché quando sei già indietro.

Dati e spirito critico

Percentuali, rischio, campioni, grafici, e soprattutto la differenza tra **correlazione e causa**. È la competenza che distingue chi sa leggere uno studio da chi ripete un titolo di giornale. Serve anche per non farsi ingannare dalla divulgazione sbagliata, che in salute fa danni reali.

Scrittura, comunicazione e inglese

Relazioni, consegne, consenso informato e spiegazioni comprensibili a chi non è del mestiere sono *parte del lavoro*, non un accessorio. L'inglese serve per articoli, linee guida, manuali e aggiornamento: non ti serve parlarlo benissimo, ti serve leggerlo senza tradurre tutto.

Relazione e confini professionali

Ascolto, rispetto, lavoro in équipe e gestione delle proprie emozioni. Un punto che si sottovaluta: saper stare vicino a una persona che soffre **senza portarsi tutto a casa** è una competenza che si costruisce, non un tratto caratteriale.

Non devi arrivare sapendo fare prelievi, medicazioni, diagnosi o manovre cliniche: sono attività con formazione, supervisione e regole precise. E non serve una «vocazione perfetta»: serve verificare, con esperienze concrete, se questo lavoro ti somiglia davvero.

3 · Risorse per iniziare da soli

Servono a capire se l'area ti piace e ad allenare l'occhio critico sulle fonti. Non sostituiscono un percorso formativo, e **nessuna di queste risorse serve per autodiagnosi**.

Istituto Superiore di Sanità ed Epicentro — gratuiti

Materiali, rapporti e comunicazioni su prevenzione, epidemiologia e salute pubblica. Usali soprattutto per *imparare a riconoscere una fonte istituzionale*: è l'esercizio più utile che puoi fare adesso. iss.it · epicentro.iss.it

Ordini e federazioni professionali — gratuiti

FNOPI (infermieri), FNOMCeO (medici e odontoiatri), FNO TSRM e PSTRP (tecnici sanitari, riabilitazione, prevenzione) pubblicano informazioni istituzionali su professioni, requisiti e regole di esercizio. Utili per capire **cosa può fare davvero ciascun profilo**, cosa che nessun sito di orientamento generico ti dirà con precisione.

Coursera, edX, OpenLearn — audit gratuito

Corsi introduttivi di anatomia, salute pubblica, biologia e metodo della ricerca. Molti si seguono gratis in *audit*; certificati e alcune funzioni si pagano. Controlla sempre la pagina di iscrizione prima di iniziare.

PubMed — gratuito

La banca dati della U.S. National Library of Medicine per abstract e riferimenti scientifici. **Consiglio pratico**: parti da *review* e pagine divulgative affidabili, non da un singolo studio isolato — un solo studio non fa una verità, e imparare questo ora ti risparmierà errori per anni. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Per esperienze dal vivo cerca musei della scienza, dipartimenti universitari, biblioteche, associazioni di volontariato e comitati locali CRI. Non esiste una banca dati nazionale unica dei laboratori aperti agli studenti: verifica di volta in volta età, costi, assicurazione e calendario.

4 · Esperienze da cercare

Qui la domanda decisiva non è «cosa mi piacerebbe fare», ma **a cosa posso accedere adesso**. In sanità i limiti di età e di ruolo sono più stringenti che altrove, ed è meglio saperlo prima di perdere un semestre.

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
PCTO sanitario	Minorenni, tramite la scuola; nessun costo. Solo attività osservative, educative o logistiche	Ufficio formazione ASL e ospedali, università, RSA, farmacie
Croce Rossa Italiana	Volontari dai 14 anni, con autorizzazione dei genitori se minorenni	Comitato CRI territoriale (regole e quote variano)
Volontariato in associazioni	Spesso minorenni con autorizzazione; dipende da statuto e assicurazione	CSV, associazioni di pazienti, ASL, ospedali
Servizio Civile Universale	Di norma 18-28 anni non compiuti: NON per minorenni	Bando annuale sul portale ufficiale

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
Erasmus+ Gioventù	Requisiti definiti dal singolo progetto; nessuna soglia nazionale unica	Scuola, associazioni accreditate, Informagiovani

Due precisazioni. Sul **Servizio Civile** alcuni enti indicano fasce leggermente diverse (CRI riporta 18-29 anni non compiuti): fa fede il bando dell'anno. Sulla **CRI**: aderire dai 14 anni non significa poter fare soccorso sanitario operativo, che richiede abilitazione e assegnazione specifiche.

Cosa aspettarti realisticamente dal volontariato prima dei 18 anni: accoglienza, raccolte fondi, informazione, eventi, supporto non clinico. L'assistenza diretta e l'accesso a cartelle o reparti richiedono maggiore età, formazione o autorizzazioni. Non è una fregatura: è la stessa logica per cui non ti fanno guidare un'ambulanza a sedici anni.

5 · Dove si lavora davvero e come sta cambiando

Non solo in ospedale. Si lavora in ASL e distretti, servizi territoriali, ambulatori, emergenza-urgenza, riabilitazione, salute mentale, assistenza domiciliare, RSA, farmacie, laboratori di analisi, centri diagnostici, ricerca clinica, industria farmaceutica e biomedicale, assicurazioni sanitarie, università, scuole, associazioni e pubblica amministrazione. Ruoli e responsabilità cambiano secondo titolo, abilitazione, ordine professionale, contratto e organizzazione.

Gruppo professionale (Excelsior, gennaio 2025)	Nel mese	Trimestre gen-mar
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali	7.090	19.250
Operatori della cura estetica	4.700	14.180

Fonte: Unioncamere-Excelsior, bollettino di gennaio 2025. Sono **entrate programmate dalle imprese rispondenti**: non assunzioni concluse, non i posti pubblici del SSN (che passano da concorsi) e non una misura completa di tutte le professioni sanitarie. Leggile come un ordine di grandezza della domanda privata, niente di più.

Tendenze da monitorare (senza leggerle come garanzie)

- Invecchiamento e cronicità: cresce il peso dell'assistenza territoriale, domiciliare e della gestione delle patologie croniche — ma questo non garantisce un posto a ogni candidato.
- Sanità digitale: fascicolo sanitario elettronico, telemedicina e dati clinici richiedono formazione, privacy e procedure; non eliminano relazione e presa in carico.
- Organizzazione territoriale: case e servizi di comunità e integrazione sociosanitaria orientano molte politiche, ma attivazione e organici cambiano molto tra regioni.
- Regole e responsabilità: protezione dei dati, consenso e sicurezza delle cure rendono documentazione e lavoro d'équipe parte sostanziale del mestiere.

La distribuzione delle opportunità varia tra regioni, pubblico e privato, concorsi, convenzioni, turni e costo della vita. **Non esiste un dato nazionale unico che dica «dove conviene lavorare in sanità»** per tutti i ruoli: confronta bandi regionali, fabbisogni, contratti e condizioni reali.

6 · Quanto si guadagna, in dettaglio

Attenzione: i numeri qui sotto sono **medie di gruppo di laureati** (AlmaLaurea), retribuzioni *nette mensili osservate tra gli occupati intervistati* — non RAL contrattuali, non stipendi d'ingresso garantiti, non il valore

di un singolo ruolo.

Gruppo (AlmaLaurea, rilevazione 2024)	Netto/mese a 1 anno dal titolo
Medico-sanitario (primo livello)	1.657 €
Medico-sanitario e farmaceutico (secondo livello)	1.660 €
Tutti i laureati di primo livello	1.492 €
Tutti i laureati di secondo livello	1.488 €

Fonte: AlmaLaurea, Rapporto 2025, rilevazione 2024 sui laureati 2023 a un anno dal titolo. Sono medie di gruppo: **non equivalgono allo stipendio iniziale di un singolo infermiere, medico, fisioterapista, farmacista o tecnico**, e non garantiscono un'assunzione. I confronti vanno fatti considerando orario, territorio, contratto e composizione del gruppo.

E per gli ITS Academy? Il Monitoraggio nazionale INDIRE 2025 ha esaminato 450 percorsi conclusi entro il 31 dicembre 2023 in 109 ITS Academy: 7.212 diplomati su 8.588 risultavano occupati a dodici mesi (84,0%), e 6.698 di essi (93%) in un lavoro coerente col percorso. Sono dati su *tutti* gli ITS e riguardano l'occupazione, non lo stipendio: **non esiste un dato nazionale affidabile sulle retribuzioni degli ITS dell'area salute e benessere**, e non va stimato da annunci isolati.

Per il SSN e le strutture private il trattamento dipende da CCNL, area o comparto, inquadramento, anzianità, turni, indennità e territorio: non esiste una retribuzione unica di «chi lavora in sanità». Quando ricevi un'offerta chiedi: è RAL o netto mensile? quante mensilità? quale contratto e quale livello? orario, notti e festivi? quali indennità? periodo di prova, sede, rimborsi? E ricorda che **tirocinio curricolare, contratto di formazione, tempo determinato, partita IVA e indeterminato non sono la stessa cosa**, nemmeno lontanamente.

7 · Gli errori da evitare all'inizio

L'errore	Cosa fare invece
Scegliere un corso solo perché «porta in ospedale».	Confronta piano di studi, tirocini, modalità di accesso, abilitazione, turni, sedi e attività reali del profilo in uscita.
Confondere l'interesse per la salute con la disponibilità a fare <i>quel</i> lavoro.	Parla con professionisti di ruoli diversi e osserva le parti non spettacolari: documentazione, équipe, igiene, turni, responsabilità.
Accettare attività cliniche senza formazione o supervisione.	Solo attività autorizzate, con tutor, nel rispetto di privacy, sicurezza e limiti dello studente. Un'esperienza «in più» non vale un rischio per un paziente.
Credere alle promesse di «lavoro garantito».	Chiedi dati con anno e fonte: numero di diplomati, quota occupata, tipo di contratto, luogo e condizioni d'accesso.
Usare social e IA come fonti cliniche definitive.	Parti da ISS, Ministero, ordini professionali e linee guida; verifica data, autore, conflitti di interesse e a chi si rivolge il testo.

Hai fatto il primo passo leggendo fin qui. Il prossimo è più piccolo di quanto pensi: scegli una micro-esperienza da iniziare questa settimana. Le missioni di KIREO sono fatte apposta per darti quel primo ciclo concreto.

Fonti

- AlmaLaurea — Condizione occupazionale dei laureati, Rapporto 2025 (rilevazione 2024) e approfondimento sulle retribuzioni.
- INDIRE — Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025 (450 percorsi conclusi entro il 31/12/2023, 109 ITS Academy).
- Unioncamere–Excelsior — bollettino di gennaio 2025.
- ANISN — Campionati delle Scienze Naturali, edizione 2026 (fase nazionale 9-11 maggio).
- Croce Rossa Italiana — volontariato, giovani e Servizio Civile.
- Istituto Superiore di Sanità ed Epicentro ISS; PubMed (U.S. National Library of Medicine).
- FNOPI, FNOMCeO, FNO TSRM e PSTRP — informazioni istituzionali sulle professioni sanitarie.
- MUR e portali di ateneo — accesso ai corsi dell'area medico-sanitaria.

Fonti consultate il 14/08/2026. Regolamenti di accesso, bandi, scadenze e dati economici cambiano ogni anno: verificali sui siti ufficiali prima di prendere una decisione.